



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : سمر محمود محمد على

العنوان : 5 ش محمد اسماعيل-
ش النصر

الحي / المدينة : المرج

المحافظة : القاهرة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

رقم البطاقة : 29701132202246 رقم التليفون : 01093563799

العمر (تاريخ الميلاد) : 13-01-1997 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك الإحصائي الاجتماعي
المقر بما فيه التوقيع: (-----) التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. ----- /د. ----- /د. ----- /د. -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سمر محمود محمد علي National ID: 29701132202246	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

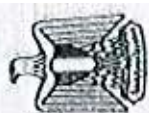
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٩٠
=



٢٠٢٢/٠٥/٢٤
٢٠٢٢/٠٥/٢٤
٢٠٢٢/٠٥/٢٤

حكومة فلسطين

مستشفى

المنطقة سارية



HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

جهة الإصدار: فرع القاهرة

تاريخ الإصدار: 2022-12-14

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي
والبحث تبين أن

السيد (ة) تيسير محمد نور حمانيه بطاقة رقم 28306230101709
وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي
وشكرا

الموظف المختص
سماح محمود



تاريخ الطباعة: 2022-12-14

إفادة مركز نظم المعلومات
يعتمد...



مسلسل 254418

يعتبر هذا الخطاب ساري لمدة شهر من تاريخ الإصدار

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و دعم القرار



Ministry of Health and Population
Kingdom of Saudi Arabia

الوزارة العامة للصحة والسكان
المملكة العربية السعودية



A-Patient ID:

1- Name: بدر محمد علي

Sex:

MDT form

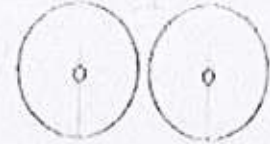
3- Med cat number:
Female

82675445
Old Med:

DATE:
15/07-2023

2- ID number: 23701152202245

Patient Age: 22 Y



Family History

Family Name

Phone

Sex
05023563299

BMI

SN

REASON OF MDT

REASON OF MDT
STAGE

Marital status

Marital Status
Single

NRS Score

NRS Score

GROUP

GROUP

Date of MDT

Date of MDT

Comorbidity

Comorbidity
Free

Menopausal status

Menopausal status

Initial stage

Initial stage

26/03/2024

05

Clinical data

Breast Imaging:

Mets Workup:

BX
IDC

ER
8/8

PR
7/8

Her 2 Neu
0

SISH

Ki67
10

ER comment
gii with major dcis

ER comment

PR comment

Her 2 Neu comment

SISH comment

T
2

N
1

M

Sonomammography

PATIENT HISTORY

It wider excision + find 20/12/2023: IDC GII + major DCIS

superior margin showed IDC GII & DCIS

superficial margin showed DCIS

IPQ done on sup. margin -> loss of myoepithelial cells

-ve for P 63

, caponin

LN 2/10 + NO EXTRACAPSULAR INVASION

LT COMPLETION MASTECTOMY: RESIDUAL Idc gii + MAJOR dcis

free deep margin

free nipple, areola PT2

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN

for adjuvant AC 4 TAXOTERE 4, ZOLADEX 1 WEEK before chemo, PORT

ZOLADEX AT AS ADJUVANT, PT was informed about all details of fertility preservation

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

Psychiatric

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Request No. : 13002920
Request Date : 20/12/2023
Verification Date : 31/12/2023
Financial Category : اورام دار السلام - ميجرو
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer.

Nature Specimen: Left Wider excision, left axillary lymph node dissection.

Gross Examination:

- * Left axillary lymph node dissection: Fibrofatty tissue piece measured 2x1.5 cm, entangling 10 lymph nodes up to 0.5x0.5 cm.
- * Left Wider excision measured 5x2x1.5 cm, with no skin covering.
- * Tumor extent: Serialing revealed grayish white ruberry area.
- Size: 3x2 cm.
- * Distance from margins: 0, 1cm from medial margin (least margin)

Microscopic Examination:

- * Histological Type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- * Ductal carcinoma in situ: Major DCIS.
- * Lymph node involvement: positive in (2/10) with no extracapsular invasion.
- * Angiolymphovascular invasion: No.
- * Perineural invasion: No.
- * Resection Margins: superior margin showed Invasive duct carcinoma GII and DCIS. Superficial margin showed DCIS.
- * IPT done on superior margin revealed loss of myoepithelial cells, negative for P63, calponin.

Diagnosis:

Left breast Wider excision and Axillary lymph node dissection:
* Invasive duct carcinoma (IDC) 100%

- * Margins are positive (details above).

Verified by :
DR.Menna Nabli

Printing Date : 09/01/2024 12:41:42

Page 1 of 2

Printing By : Ali mostafa



غرفة رقم (4) - الدور الثاني - مجلس رقم (987) - كورنيش النيل .. مصر (2007) - 2008
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذة / منى محمود محمد علي
Patient No. : 29701132202246
Path No. : 4506/23
Sex : Female
Age : 26 Y
Referring Doc :

Request No. : 13002920
Request Date : 20/12/2023
Verification Date : 31/12/2023
Financial Category : أورام دار السلام - مينا
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

* Lymph node involvement: positive in (2/10) with no extracapsular invasion.

Signature
Prof. Dr. Iman Gouda.
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 02/01/2024 12:41:42

Page 2 of 2

Printing By : Ali mostafa



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mar El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / منى محمود محمد ناصي

Patient No. : 29701132202246

Path No. : 430/24

Sex : Female

Age : 27 Y

Referring Doc. :

Request No. : 13003274

Request Date : 30/01/2024

Verification Date : 19/03/2024

Financial Category : نورام دار السلام - مياثرة

Department : Out Patient

IHC No. :

Registered by : marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical data: Left breast cancer

Nature of specimen: Left completion mastectomy

Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against ER clone (1B2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:

IPT (Positive control showed appropriate reactivity):

ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8 /8).

PR: Strong nuclear reaction in 60% of tumor cells (score 7 /8).

Her2: No membrane reaction in the tumor cells (score 0).

Ki67: 10% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:

Left completion Mastectomy:

Residual Invasive duct carcinoma, grade II with major DCIS

Free deep margin

Free nipple and areola

Stage : pT2

PT:

ER: Positive (score 8 /8)

PR: Positive (score 7 /8)

Her2: Negative (score 0).

Verified by :

DR Monira Nabil

Printing Date : 19-03-2024 11:59:29

Page 1 of 2

Printed By : marwa mohamed yousse

Patient Name: (الاسم) / اسم المريض
Patient No.: 29701132202246
Path No.: 430/24
Sex: Female
Age: 27 Y
Referring Doc:

Request No.: 13003274
Request Date: 30/01/2024
Verification Date: 19/03/2024
Financial Category: اورام دار السلام - مبانى
Department: Out Patient

Registered by: marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Ki67: Positive in 10% of tumor cells.

Scoring system: "ER, PR"

SCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, 1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 7%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013 IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or incomplete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Prof. Dr. Iman Gouda
Dr. Mohamed torky

Verified by :
OR Monna Nabil

Printing Date: 19/03/2024 11:59:29

Page 1 of 1

Printed By : marwa mohamed yousse

Patient Name: Samar Mahinoud Mohamed Ali	Date: 17/01/2024
Exam: C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age: 27 Year(s)
Medical ID: 450712023	

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

Left CBS for pre-operative assessment before MRM.

1. Chest:

- Left axillary cystic lesion ? seroma measures 1.7 x 2.3 cm.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:

- The scanned skeleton shows no lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

Patient Name: Samar Mahmoud Mohamed Ali	Date: 17/01/2024
Exam: C.T. ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age: 27 Year(s)
Medical ID: 4507/2023	

OPINION:

- No CT evidence of definite pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.

Dr. Wafaa Ali, MSc.

Signature Prof. Menna Talla Hanafy
19/01/2024 06:18